

40. 체중감소

- 중요 포인트

일차의료에서 흔한 증상, 심한 경우에는 원인을 찾아 근본적인 치료해주기

- Overview

키/체중/복부둘레: 현재 얼마. 얼마만큼의 기간동안 몇 kg 빠졌는지 확인

-> 의미있는 체중감소인가? (6개월간 체중의 5% 이상)

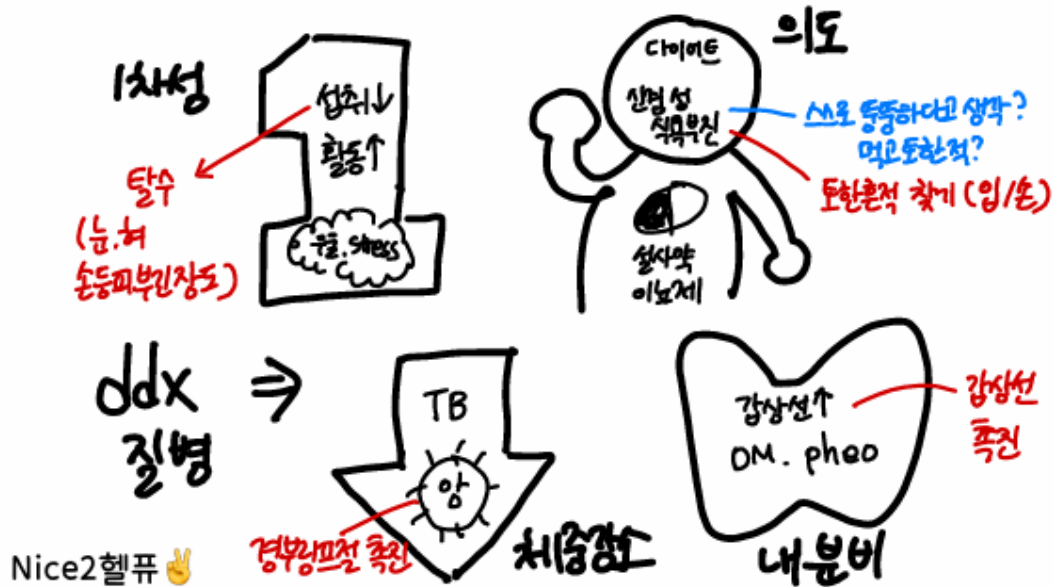
수의성 vs 불수의성 -> 일부러? 의도성/식욕 평가; 다이어트/운동 증가/식사량 감소

2차성 문진 -> 호흡/소화/내분비(당, 갑, 갑)/정신

신체진찰 시 TB 이면 폐진찰 Full 로 진행

PPI 신경쓰기. 공감. 교육 자세히

26. 체중감소 몇kg에서 몇kg로? / 기? 그림으로 시작하는 CPX



- 평가 목표

원인	
수의적	에너지 섭취 감소: 약물(항우울제, 다이어트약, 설사약), 식이요법/섭식장애(우울, 식욕부진) 에너지 소모 증가: 운동과다, 직업
불수의적	식욕감소: GI 질환, 정신질환, 약물 등 에너지 소실 증가: 당뇨, 갑상샘항진증, 신생물, 만성질환 등
평가목표	
1) 의미 있는 체중 감소를 구별 2) 불수의적 체중 감소의 원인 감별	
구체적인 성과	

병력 청취	체중감소 양상 확인		임상적 유의성: 6개월~1년 사이 평소 체중의 5% 이상 실제 변화: 몇 kg에서 현재 몇 kg 속도와 기간				
	수의적 에너지 섭취와 소모 변화 확인		에너지 섭취: 최근 식사량 변화, 다이어트 에너지 소모: 운동량, 직업/환경변화 심리: 우울증이나 적응장애로 식욕 부진				
	체중감소 유발하는 기질적 원인 감별		식사량이 그대로인데 빠진다 - 당뇨병: 다음/다뇨/다갈 - 갑상샘항진증: 더위불내성/피로 - 흡수 장애: 변이 기름지거나/설사 식사량이 줄면서 빠진다 - 악성 종양: 발열/밤에 식은땀/가죽력 - 만성 감염: 2주 이상의 기침/가래 (TB) - 정신과: 우울증, 거식증				
신체 진찰	신체계측을 통해 체중감소 확인		BMI 측정: BMI = kg/m ² 허리둘레: 배꼽 높이에서 측정 (복부비만 : 남≥90cm, 여≥85cm)				
	기질적 질환 감별 위한 신체진찰		두경부: 결막, 갑상샘, 림프절 촉진 (갑상, 암) 흉부: 호흡음, 심음 청진 복부: 시-청-타-촉 -> 장음항진(흡수장애), 간비비대/종괴 사지: 손떨림(갑상), 부종, 황달(GI 암)				
진단 및 치료	1. 원인을 감별할 수 있는 진단계획 수립 2. 원인에 따른 치료계획 수립						
	기본검사 및 치료		혈액검사, 갑상샘기능검사, 흉부 X- ray, 대변 잠혈검사		식사요법, 운동요법을 통한 체중감량 약물치료, 동반질환 치료		
	원인 감별	일차성 / 약물유발				생활습관 교정 / 약물 중단	
		내분 비	갑상샘기능항진증		갑상샘기능검사		항갑상샘제
			크롬친화세포종		24시간 소변 메타네프린		부신절제술
			당뇨병		혈당검사		혈당강하제, 인슐린 주사
		호흡	COPD/폐암		PFT, CXR, ABGA		기도확장제, 산소치료
			TB		객담 항산염색, 배양		항결핵제
		소화	위암/대장암		위내시경, 복부 CT		위절제술, 항암 치료
			짧은장증후군		복부초음파, AXR		TPN, 지사제
			IBD		대장내시경, 복부 CT		설파살라진, 스테로이드, 영양공급
		정신	주요우울증		Beck 우울척도검사		항우울제(SSRI, TCA), 전기경련요법
			신경성 식욕부진		전해질검사		영양 공급 및 입원 치료
환자 교육	체중관리를 위한 생활습관 교육		식습관 개선: 규칙적인 식사로 3끼 식사 거르지 않기 스트레스: 취미생활을 가지거나 요가 명상 등 추천				
PPI 및 주의 사항	① 병력청취 시 올바르게 못한 생활습관이 나오더라도 중립적으로 들은 뒤 교육에서 생활습관 교정해주기 ② 체중관리 어려움에 공감 표하기 ③ 당뇨의 경우 합병증과 혈당 관리의 중요성 설명 ④ 거식증의 경우 자신에 대한 잘못된 인상 교정 & 20% 이상 감소거나 내과적 문제 심각 시 입원 권유						

• 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료	
1 차성	1 차성 체중감소 2+1	활동량보다 음식 섭취가 더 많아 남는 E 가 몸에 지방이 쌓임	특이한 원인이 없음. 스트레스, 식수량 감소	복부비만	기본검사 :혈액검사,TFT,소변검사	생활습관 개선	
	약물	약물유발 체중감소	설사약, 다이어트약, 정신과약 등의 복용력			약물 중단	
	소화	위암/대장 암 1+1	복용 중인 약물이 식욕 둔우거나 수분 불잡음	소화불량, 혈변/흑색변 위내시경에서 이상소견	위내시경, 복부 CT	내시경적 절제, 수술, 항암	
	짧은장증 후군	스테로이드 호르몬이 과해져 지방이 얼굴과 복부에 집중적으로 쌓임	이전 수술로 장 절제	buffalo hump 복부 시진 – 자색선조, 복부비만	복부 초음파, x-ray	TPN, 지사제, 콜레스티라민	
	IBD 1		혈변, 심한 복통, 탈수 체중 감소	복부 압통 장음 감소 DRE 혈변	대장내시경 대장조영술 복부 CT	설파살라진, 스테로이드 충분한 영양공급	
	호흡	COPD/ 폐암	몸 대사가 느려져 에너지 잘 태우지 못하고 쉽게 부음	고령, 가래, 흡연자, 호흡곤란, 객혈 / 쌉쌉거림	갑상샘종대, 하지부종	CXR, ABGA, 폐기능검사	기관지 확장제 / 수술, 항암
	결핵 2	여성호르몬 감소로 기초대사량이 떨어짐	발열, 피로, 체중감소, 객혈, 야간발한	골반진찰	객담 염색, TST	항결핵제	
	내분비	당뇨병 2+1	심장 힘이 약해져 혈액 잘 못 짜줘 수분이 혈관 밖으로 나와 몸 부음	다음, 다뇨, 다갈, 체중감소, 소변단내	경정맥 확장, 다리부종	혈당검사, 소변검사	혈당강하제, 인슐린, 식습관 조절
		갑상선항 진증 1+1	인슐린 저항성 생겨 혈당조절 잘 안되고 지방축적	체중감소, 더위불내성, 설사	골반진찰	TFT	PTU, MTZ
크롬친화 세포종		부신에 생긴 종양이 카테콜아민을 과도하게 만들어 대사 증가	두통, 안면홍조, 발한 두근거림, 기립성저혈압	복부 촉진	24 시간 소변 메타네프린, 복부 CT	부신절제술	
정신	우울증	공팔이 물 제대로 못 걸러서 고임	우울, 의욕저하, 식욕저하, 집중력 저하 등	하지부종	우울척도검사	항우울제, 전기경련치료	
	신경성식 욕부진	공팔에서 단백질이 빠져나가 혈액에 적어져서 부음	젊은 여자, 본인이 살쥔다고 생각, 생리 불규칙, 구토제 사용 구토 흔적(Russel's sign)		전해질검사	영양공급, 입원치료	

O	언제부터 체중이 빠지기 시작했나요? 언제 인지? 갑/서	
L	특히 더 빠진 부위가 있나요?	
D	지속적으로 빠진건가요?	
Co	[의미있는 체중감소] 임상적 유의성: 6개월~1년 사이 평소 체중의 5% 이상 설명 그 기간동안 몇 kg에서 몇 kg로 살이 빠졌나요?	
Ex	이전에도 이런 적 있으셨나요?	
Ch	현재 정확한 키/몸무게/허리둘레 가 어떻게 되나요? (BMI 계산) (복부비만 : 남≥90cm, 여≥85cm) 인위적으로 체중 감소를 위해 운동량/식사량 조절/약물을 하셨나요?	
A	전신) 발열/오한/피로 호흡장애) 음식을 씹거나 삼키는데 불편하신가요? 호흡) 기침/가래/객혈/호흡곤란/야간 발한 r/o 폐암, COPD, TB 소화) ANVCD + 복통/소화불량 + 토혈/혈변/흑색변 r/o 위암/대장암, IBD 내분비) 더위불내성/두근거림 r/o 갑상샘기능저하증 두통/기립성 저혈압 r/o 크론친화세포종 다음/다뇨/다갈 r/o 당뇨병 정신) 우울/의욕저하 r/o 우울증 본인의 체형에 대해 어떻게 생각하시나요?(스스로 뚱뚱) 일부러 구토를 한 적이 있나요? r/o 신경성 식욕부진	
F	최근 스트레스? 해외여행? r/o 식중독	
E	마지막 건강검진? 위/대장내시경?	
외	최근 다친 곳? 위/대장 수술받은 적? r/o 짧은창자증후군	
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본: 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 갑상선/정신과	
약	복용중인 약물? 다이어트약, 항우울제, 설사약 일일히 확인	
사	기본: 음주/흡연/스트레스 직업: 활동량이 어느정도인가요? 주로 앉아있는 직업/신체활동이 많은 직업? 식습관: 규칙적/식사량/외식/야식/육류나 기름진음식 + 어제 하루동안 먹은 식단 알려주세요 운동: 평소 운동은 규칙적으로 하세요?	
가	고혈압/당뇨/고지혈증 암 가족력	
여	월경력: 규칙적/생리량/월경통/LMP + 임신가능성!	
PEx	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 키/체중/허리둘레 측정 1 눈: 빈혈 2 입: 탈수 + 토하거나 토혈 흔적 3 목: 갑상샘 촉진, 림프절 촉진 r/o 갑상선항진증, 암 4 사지: 손등 피부긴장도, 손떨림, 러셀 사인(손등 상처) r/o 신경성 식욕부진 하지 오목부종 5 흉부: 호흡음, 심음 결핵 의심 시 호흡기 진찰 Full로 진행
	누워서	㉔ 복부: 시-청-타-촉
	DRE	크론병/대장암 등 가능한 CC니까 나오더라도 당황 X

PPI	병력청취 시 올바르게 못한 생활습관이 나오더라도 중립적으로 들은 뒤 교육에서 생활습관 교정해주기 [4가지 포함되도록: 저체중의 위험 - 추정 진단 - 검사 - 치료/생활습관 교정 자세히]
진단	지금 가장 걱정되는게 있으신가요? 공감/안심) 살이 이전보다 많이 빠져서 걱정되셨을 것 환자분은 6개월 동안 평소 체중의 5% 이상 감소했기 때문에 의미있는 체중감소로 보입니다.

	추정진단) 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~으로 이 때문에 체중이 감소된 것으로 보여집니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다.		
검사, 치료	기본 검사	① 혈액검사 ② 갑상샘기능검사, 혈당검사 ③ 흉부 X-ray ④ 소변검사: 소변 유리 메타네프린, 임신반응검사	
	기본치료	① 식사요법, 스트레스 관리 통한 체중증량 ② 원인질환 치료 ③ 수액치료 (영양 보충)	
	일차성 체중감소		기본검사
	약물유발 체중감소		식습관 개선, 스트레스 관리
	내분비	갑상샘항진증	갑상샘기능검사
		크롬친화세포종	항갑상샘제
		당뇨병	부신절제술
	호흡	COPD/폐암	24 시간 소변 메타네프린
		결핵	혈당검사
	소화	위암/대장암	항갑상샘제, 인슐린 주사
교육	안심 갑상샘항진증/결핵(크론병) 원인질환 치료를 통해 체중 정상화 가능		
	진단검사		
	치료/합/응		
	합병증-오랜기간 심한 저체중 시 골다공증, 근력약화, 불임 등의 합병증 주의!		
	교정/회피		
	식습관 개선) 가장 중요!		
	열량 섭취 부족하지 않게 하루 3 끼 거르지 않고 먹기		
	야식 및 간식은 오히려 식사량이 줄어 칼로리 공급 부족 유발하기에 지양		
	운동량 개선)		
	과도한 운동은 피하고 입맛 돌정도로 규칙적 운동		
	스트레스 개선)		
	취미생활 권유 - 요가나 명상 등		
	적당한 휴식		

	당뇨) 합병증과 혈당 관리의 중요성 설명		
	거식증) 자신에 대한 잘못된 인상 교정 & 20% 이상 감소거나 내과적 문제 심각 시 입원 권유		
PPI	① 환자를 비난하거나 판단하지 않고 환자에게 격려 ② 체중증량의 어려움 공감하기		